Informe de Urgencias
Informe d'Urgències

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO / IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE	
SERVICIO DE SALUD SERVEI DE SALUT	Conselleria de Sanitat - GVA
DENOMINACIÓN DEL CENTRO DENOMINACIÓ DEL CENTRE	HOSPITAL GENERAL DE CASTELLON
UNIDAD ASISTENCIAL RESPONSABLE UNITAT ASSISTENCIAL RESPONSABLE	Servicio de Urgencia Hospitalaria
SERVICIO SERVEI	TRAUMATOLOGIA
NÚM.DE EPISODIO NÚM.D'EPISODI	
FECHA DE INGRESO DATA D'INGRÉS	24/01/2026
FECHA Y HORA DE ALTA DATA I HORA D'ALTA	24/01/2026

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE / IDENTIFICACIÓ DEL PACIENT			
PRIMER APELLIDO PRIMER COGNOM			
SEGUNDO APELLIDO SEGON COGNOM			
NOMBRE NOM			
CIP DE LA CA CIP DE LA CA		Nº Hª CLÍNICA Nº Hª CLÍNICA	
CIP EUROPEO CIP EUROPEU		CÓDIGO SNS CODI SNS	
SEXO SEXE	SEX2	F. NACIMIENTO D. NAIXIMENT	09/11/1938
DIRECCIÓN DIRECCIÓ			

Datos generales del paciente / Dades generals del pacient

Procedencia / Procedència: PARTICULAR

Motivo de la atención / Motiu de l'atenció: .

Antecedentes / Antecedents: No RAM

Antecedentes personales
- Dislipemia.
- Ictus vertebrobasilar en septiembre 2021.
- Deterioro cognitivo desde ingreso por ictus vertebrobasilar en estudio por Neurología.
- Elevación hemidiafragma derecho.
- Insuficiencia tricuspídea moderada.
- TEP (varios) en seguimiento por Neumo (anticoagulada)
- TVP
- SAOS
- EPOC

Tratamiento habitual:
Hidroferol (Vit D) 0,266mg, sol oral de 1,5ml 1 sol oral/30 días
Rivaroxaban 20mg 1 comp/24h
Haloperidol en sol gotas de 10 gotas orales/24h
Acetilcisteina 600mg 1 comp /24h
Cefuroxima 500mg 1 comp/12h

Deambulación previa con ayuda de andador

Enfermedad o proceso actual / Malaltia o procés actual: Paciente mujer de 87 años que acude remitida desde AP por posible fractura de cadera derecha tras caída en su domicilio

Exploración física / Exploració física:

CADERA DERECHA:
MID en actitud normal
No dolor a la palpación de trocánter mayor ni ingle
No dolor a las rotaciones
BA limitado por dolor pero flexoextension de cadera posible
ENV distal correcto

Exploraciones complementarias / Exploracions complementaries: Rx cadera derecha y pelvis: sin trazos de fractura aguda aparentes

Diagnóstico principal / Diagnòstic principal: COXALGIA DERECHA POSTRAUMATICA

Tratamiento al alta / Tractament a l'alta:
- Reposo relativo
- Mantener la pierna en algo en domicilio durante el reposo
- Durante la primera semana mantener vida cama-sillon y realizar transferencias con ayuda de andador. Posteriormente utilizar poco a poco andador apra deambulacion

- Frio local 15 minutos 3-4 veces al día
- Metamizol 575mg 1 comprimido cada 8 horas. Si más dolor Paracetamol 1 gr 1 comprimido cada 8 horas (4 horas tras Metamizol).
- Control por su MAP
- si empeoramiento clínico acudir de nuevo a urgencias

Circunstancias al alta / Circumstàncies a l'alta: MÉDICO DE CABECERA

Responsable:

Firma digital / Signatura digital:

RESIDENTE

Sección / Secció: TRAUMATOLOGIA

Fecha / Data:

Fecha creación / Data creació: 24/01/2026